尿路感染の理解と対策について
～「いつもと違う」に気づき、日々の排泄ケアで防ぐ～

Gemini Notebook

尿路感染の予防と早期発見は、全職種の連携で成り立ちます



Gemini Notebook

尿路感染症とは？（上行性感染）

尿路は本来「無菌」。腸内細菌（大腸菌など）が逆流して増殖します。



尿路性敗血症
全身状態の悪化、命の危険

腎盂腎炎
高熱、悪寒、腰背部痛

膀胱炎
頻尿、排尿痛、尿のにごり

Gemini Notebook

高齢者・施設入居者に多い「6つの理由」

体の構造

女性は尿道が短い、
男性は前立腺肥大



おむつ・失禁

陰部が不潔になり
やすい（便の汚染）



免疫力低下

加齢や疾患により
感染への抵抗力が弱い





水分不足

尿量が減り、菌
を外へ洗い流せない



便秘

腸に便がたまると
膀胱を圧迫し残尿が増える



カテーテル

管を伝って細菌が直接
入り込む（最大の危険因子）



Gemini Notebook

【最重要】高齢者の症状は「わかりにくい」

一般的な症状	高齢者に多い現れ方
排尿時の痛み・頻尿	痛みを訴えない、急に失禁が増える
高熱・悪寒	熱が出ない、または37℃台の微熱のみ
尿の濁り・血尿	なんとなく元気がない、食欲低下、 急に混乱する（せん妄）、転倒する

「いつもと違う（急なADL低下や不穏）」が最大のサインです

Gemini Notebook

緊急対応！敗血症を疑う「危険なサイン」

高齢者の敗血症の致死率は10〜30%。
夜間・休日でも直ちに看護職員・医師へ報告してください。



- ☐ 寒気やふるえ（悪寒戦慄）を伴う高熱
- ☐ 反応が悪い、意識がもうろうとしている
- ☐ 呼吸が速い、苦しそう
- ☐ 手足が冷たく顔色が悪い、血圧低下
- ☐ 尿がほとんど出ていない

Gemini Notebook

「尿が濁っている＝すぐ抗菌薬」の誤解

無症候性細菌尿

- 症状がなくても尿に細菌がいる状態。
- 施設入居者の女性最大約50%、男性最大約40%に見られる。
- 尿の濁りやにおいは、水分不足でも起こる。



不要な抗菌薬の害

- 本当に効く薬がなくなる(薬剤耐性菌の発生)。
- 下痢などの副作用。
- 本当の不調の原因(脱水、便秘など)を見逃す危険。

尿だけで判断せず、「全身状態」とセットで観察することが必須です。

Gemini Notebook

明日からできる予防策① 水分補給と排泄ケア

水分補給

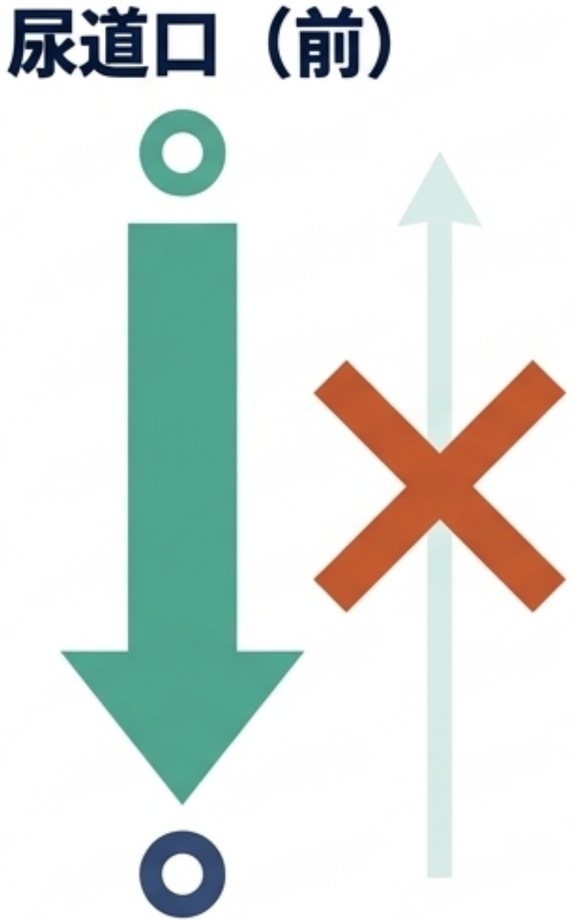
- 十分な尿量で細菌を膀胱から洗い流す。
- 起床時・入浴前後など、時間を決めてこまめに。
- 「〇〇mL」と具体的に記録する。

排泄ケア

- 「座位姿勢」での排泄を支援し、残尿を減らす。
- 尿意のある時間にトイレへ誘い、我慢させない。
- 便秘を予防する（腸が膀胱を圧迫するため）。

Gemini Notebook

明日からできる予防策② 陰部の清潔



必ず「前から後ろへ」

逆方向は便の細菌（大腸菌）を
尿道に運んでしまう。

一度拭いた面で繰り返さない

常に新しい面を使用する。

速やかな交換と洗浄

便失禁後は特に丁寧に。
こすりすぎず微温湯と洗浄剤で洗う。

Gemini Notebook

明日からできる予防策③ 標準予防策（手指衛生）

入居者 A
（尿/便）



入居者 B / 環境

手袋のルール

１ケアごとに交換。
汚れた手袋でベッド柵、衣類、記録用具に絶対に触れない。

動線管理

おむつカートは清潔なものと汚れたものを完全に分ける。

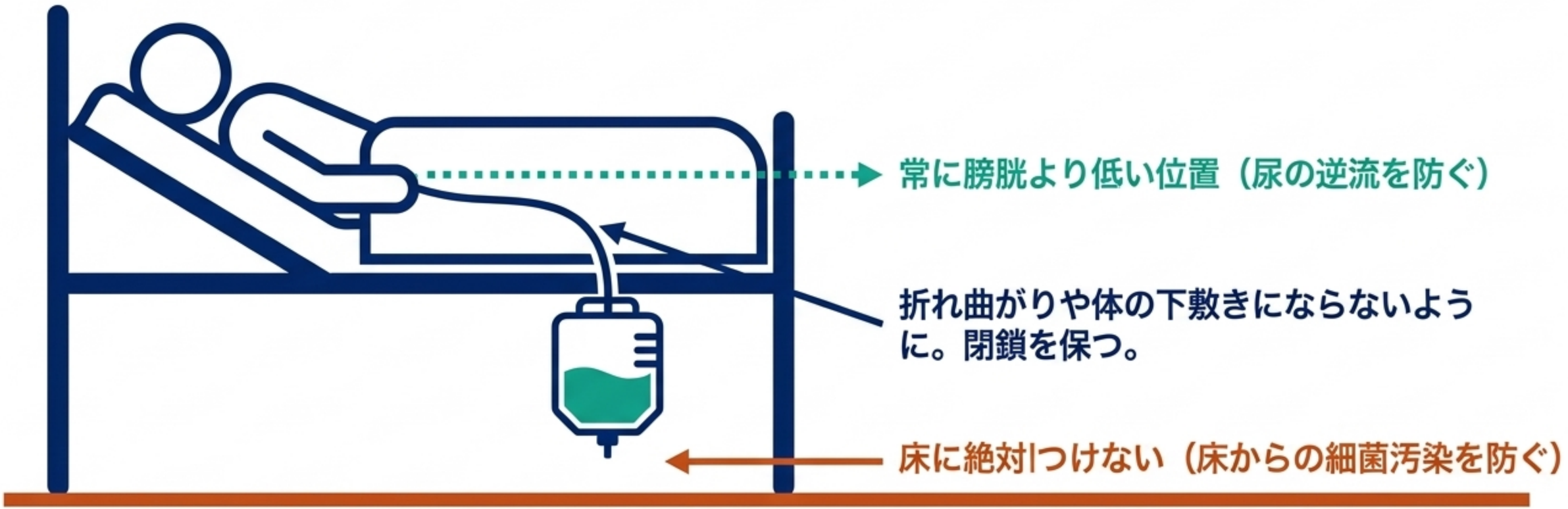
共用物品

尿器や陰部洗浄ボトルは個人専用か、使用ごとの洗浄・消毒を徹底。

Gemini Notebook

カテーテル管理の鉄則（最大の危険因子）

「不要なカテーテルは使わない・早く抜く」が最大の予防



注意：日常的な膀胱洗浄や定期的な消毒は、耐性菌の原因になるため行いません。

Gemini Notebook

薬剤耐性菌（AMR）を施設に広げないために

不適切な抗菌薬使用
カテーテル長期留置
→ 薬剤耐性菌の発生
→ 手や物品を介して伝播

全員に対する標準予防策の徹底

保菌者を特別扱い・隔離するのではなく、「誰が保菌しているか分からない」前提でケアを行う。

処方の遵守

医師の指示通りに抗菌薬を最後まで飲み切る支援。自己判断で中断しない。

不要な薬を減らす

尿のにおいだけで安易に抗菌薬を求めない。

Gemini Notebook

早期発見のための「報告フレームワーク」

「尿が臭いです」だけの報告はNG。看護・医師が正しく判断できる情報を伝えましょう。

1. **【誰が・いつから】**
   例：「2階のBさんが、今朝から…」
2. **【全身の様子】**
   例：「いつもより元気がなく、朝食を半分残しました。落ち着きがありません」
3. **【バイタル】**
   例：「体温37.3℃（微熱）、脈拍90です」
4. **【尿・水分・排便】**
   例：「尿は濃く少量、昨日の水分は500mL、排便は3日ありません」
5. **【依頼】**
   例：「一度見ていただけますか」

Gemini Notebook

ケーススタディ：こんな時、どう考える？

急に落ち着かないAさん

状況：認知症のAさんが急に不穏。微熱、尿は濃く少量。

思考：尿路感染症だけでなく、脱水や便秘の可能性も疑う。全身状態の報告が必須。

家族からの「薬を出して」

状況：家族が「尿が臭いから薬を」と要求。本人は元気。
思考：無症候性細菌尿の可能性が高い。全身状態が良ければ抗菌薬は不要であることを多職種でどう説明するか。

車いすの蓄尿バッグ

状況：車いすの肘掛けにバッグが掛かってている。
思考：膀胱より高い位置はNG。そもそも「このカテーテルは今も必要か？」を定期的に見直す時期かもしれない。

Gemini Notebook

まとめ：排泄の尊厳と明日からの実践

尿路感染症の予防は、「おむつを清潔に保つこと」だけではありません。
できる限りトイレで、自分のタイミングで排泄できる支援が、
尊厳を守り、結果として感染予防に直結します。

1. 「なんとなくいつもと違う」を全身から見つける。
2. 尿のにおいだけで判断せず、水分・排便とセットで観察する。
3. 標準予防策（手袋の適切な交換・前から後ろへの清拭）を徹底する。

Gemini Notebook